

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070212-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARIANA BELO LUCIO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIABETES MELITUS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E ACESSÓRIOS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. @ref, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5070212-49.2024.4.02.5101

510014464955 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070212-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARIANA BELO LUCIO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão de evento 13, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos para controle da taxa glicêmica da autora, portadora de diabetes mellitus tipo 1.

Requer a parte recorrente o deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, já ter feito uso de todas as opções fornecidas pelo SUS, incluindo insulina, NPH e regular, porém, não obteve sucesso. Informa, ainda, que a diabetes mellitus é uma doença crônica que até o presente momento não possui cura, sendo caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose ou seja, pela ausência total de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, que é o responsável pela manutenção da taxa de glicose no sangue em níveis normais.

Aduz que atualmente faz uso diário de “Caneta de Insulina Basaglar” e de análogo de ação rápida, com melhora em comparação ao tratamento anterior, porém, ainda apresentando variabilidade glicêmica.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

Pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da tutela recursal (evento 14, PED RECONSIDERAÇÃO1).

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

Inicialmente, conheço da presente medida eis que tempestiva e adequada.

Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde e ao incumbe ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde. A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

In casu, a recorrente é portadora diabetes mellitus tipo I, realizando acompanhamento médico junto ao Hospital Federal da Lagoa (evento 1, ANEXO2), sendo-lhe prescrito bomba de infusão de insulina e acessórios para controle de taxa glicêmica.

*O juízo a quo, por sua vez, ao apreciar o pedido de tutela de urgência na origem, concluiu, baseando-se no parecer do NAT de evento 10, PARECER1 que os insumos requeridos são **prescindíveis para o tratamento da autora** ante a existência de outras alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, em especial, a possibilidade de aplicação de múltiplas doses de insulinas por via subcutânea durante o dia.*

*Logo, ainda que haja indicação para o quadro clínico da paciente, conforme laudo médico, o fato de existirem outras alternativas terapêuticas gratuitamente disponibilizadas **impede o deferimento específico em cognição sumária**, sendo necessária maior dilação probatória a fim de se aferir o esgotamento ou não das vias disponibilizadas pelo SUS. Em outras palavras, não pode ser considerado apenas o laudo unilateralmente juntado pela autora já que o parecer do NAT não o corrobora.*

Por fim, destaco o seguinte trecho do parecer do NAT que enfatiza que a CONITEC recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para casos de diabetes tipo 1, pois os estudos realizados não forneceram evidências suficientes que comprovassem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido, veja-se:

Elucida-se, ainda, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, **mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c** (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) considerou que **as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia**⁴.

Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a **não incorporação no SUS** do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido⁵.

Assim, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão a quo é medida que se impõe em prestígio ao princípio da imediatidade da prova.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** a tutela de urgência, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório e à vista da existência de alternativas terapêuticas gratuitamente disponibilizadas, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela recursal, pois ausente o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a sua concessão.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. @ref